OTEZLA®
APREMILAST
Comprimidos recubiertos

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA:

Los comprimidos de 10 mg contienen:
Apremilast…….10 mg
Excipientes: celulosa microcristalina 26,25 mg, lactosa monohidrato 60 mg, croscarmelosa sódica 3 mg, estearato de magnesio 0,75 mg, Opadry II 85F94245 Rosa 4 mg.

Los comprimidos de 20 mg contienen:
Apremilast…….20 mg
Excipientes: celulosa microcristalina 52,5 mg, lactosa monohidrato 120 mg, croscarmelosa sódica 6 mg, estearato de magnesio 1,5 mg, Opadry II 85F165037 Marrón 8 mg.

Los comprimidos de 30 mg contienen:
Apremilast…….30 mg
Excipientes: celulosa microcristalina 78,75 mg, lactosa monohidrato 180 mg, croscarmelosa sódica 9 mg, estearato de magnesio 2,25 mg, Opadry II 85F17424 Beige 12 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Inmunosupresores selectivos. Código ATC: L04AA32

INDICACIONES Y USOS:

Artritis Psoriásica

Otezla solo o en combinación con Fármacos Modificadores de la Enfermedad Antirreumáticos (FAMEs) está indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica (APs) activa en pacientes adultos que han tenido una respuesta inadecuada, o han presentado intolerancia al tratamiento previo con FAMEs.

Psoriasis

Otezla está indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas crónica de moderada a grave en pacientes adultos, que no han respondido o tienen contraindicado o no toleran otro tratamiento sistémico, incluyendo ciclosporina, metotrexato o psoraleno y luz ultravioleta (PUVA).

Propiedades farmacodinámicas

ACCIÓN FARMACOLOGÍA:

Mecanismo de acción
Apremilast, una molécula pequeña oral inhibidora de la fosfodiesterasa 4 (PDE4), trabaja intracelularmente para modular una red de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. La PDE4 es una PDE específica de la adenosina monofosfato cíclica (cAMP) y la PDE dominante en las células inflamatorias. La inhibición de la PDE4 eleva los niveles intracelulares de cAMP, que a su vez disminuyen la respuesta inflamatoria modulando la expresión de TNF-α, IL-23, IL-17 y otras

citoquinas inflamatorias. El AMP cíclico también modula los niveles de citoquinas anti-inflamatorias tales como IL-10. Estos mediadores pro y antiinflamatorios han estado implicados en la artritis psoriásica (PsA por sus siglas en inglés) y psoriasis (PSOR por sus siglas en inglés).

Farmacodinámica clínica

En estudios clínicos en pacientes con artritis psoriásica, apremilast moduló significativamente, pero no inhibió completamente, los niveles de proteína plasmática de IL-1α, IL-6, IL-8, MCP-1, MIP-1β, MMP-3 y TNF- α Después de 40 semanas de tratamiento con apremilast, hubo una disminución en los niveles de proteína plasmática de IL-17 e IL-23, y un aumento en IL-10. En ensayos clínicos en pacientes con psoriasis, apremilast disminuyó el espesor epidérmico de la lesión cutánea, la infiltración de células inflamatorias y la expresión de genes proinflamatorios, incluyendo la óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS), IL-12 / IL-23p40, IL-17A, IL- 22 y IL-8.

Electrofisiología cardíaca

Apremilast administrado a dosis de hasta 50 mg dos veces al día, no prolongó el intervalo QT en sujetos sanos.

Experiencia en ensayos clínicos

Esta sección presenta los datos de tres (3) estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo en pacientes con PsA activa a pesar del tratamiento previo con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARDS por sus siglas en inglés) incluyendo biológicos, un (1) estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en pacientes con PsA activa que tomaban DMARD por primera vez y dos (2) estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo en pacientes con psoriasis en placas, de moderada a grave. Se proporcionan más detalles sobre los estudios individuales en las secciones siguientes.

Experiencia en ensayos clínicos con pacientes con artritis psoriásica previamente tratados con DMARDS.

La seguridad y la eficacia de Otezla se evaluaron en 3 estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo (Estudios PALACE 1, PALACE 2 y PALACE 3) de diseño similar en 1.493 pacientes adultos con PsA activa (≥ 3 con articulaciones inflamadas y ≥ 3 con articulaciones sensibles) a pesar del tratamiento previo con DMARD, incluyendo tratamiento biológico con DMARD (por ejemplo, bloqueadores de TNF) o tratamiento actual con terapia DMARD oral.

Los pacientes en estos estudios tuvieron un diagnóstico de PsA durante al menos 6 meses. También se requirió una lesión cutánea psoriásica (de al menos 2 cm de diámetro) en el PALACE 3. Se excluyeron los pacientes con fracasos terapéuticos de > 3 agentes para la PsA (moléculas pequeñas o biológicas), o de > 1 bloqueador biológico del TNF. Se incluyeron los pacientes con cada subtipo de PsA en los 3 estudios, incluyendo poliartritis simétrica (62,0%), oligoartritis asimétrica (26,9%), artritis articular distal interfalángica (DIP por sus siglas en inglés) (6,2%), artritis mutilante (2,7%) y espondilitis predominante (2,1%). Se inscribieron pacientes con entesitis preexistente (63%) y dactilitis preexistente (42%). Se les permitió a los pacientes recibir dosis estables de metotrexato concomitante (MTX) (≤ 25 mg / semana), sulfasalazina (SSZ) (≤ 2 g / día), leflunomida (LEF) (≤ 20 mg / día), corticosteroides orales a dosis bajas (equivalentes a ≤ 10 mg de prednisona al día), y/o antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) durante el ensayo; no se estudió la combinación de apremilast con DMARDs biológicos.

En los 3 estudios, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a placebo (n = 496), Otezla 20 mg (n = 500), u Otezla 30 mg (n = 497) administrados oralmente dos veces al día. Las asignaciones del tratamiento se estratificaron basándose en el uso de DMARD de moléculas pequeñas al inicio en los estudios PALACE 1, PALACE 2 y PALACE 3. Se produjo una estratificación adicional de la superficie corporal (BSA ≥ 3% con psoriasis en PALACE 3).

Los pacientes recibieron tratamiento concomitante con al menos un DMARD (65,2%), MTX (54,5%), SSZ (9,0%), LEF (7,4%), dosis bajas de corticosteroides orales (13,9%) y AINEs (70,7%). El tratamiento previo con DMARD de moléculas pequeñas se informó en el 76,4% de los pacientes y el tratamiento previo con DMARD biológicos se informó en el 22,4% de los pacientes, que incluye un 7,8% que tuvo un fracaso terapéutico con DMARD biológico previo. La duración media de la enfermedad PsA fue de 5 años.

El criterio de valoración primario fue el porcentaje de pacientes que lograron una respuesta de 20 según el Colegio Americano de Reumatología (ACR por sus siglas en inglés) en la Semana 16. Los pacientes cuyos recuentos de articulaciones sensibles e inflamadas no habían mejorado al menos en un 20% fueron considerados no respondedores en la Semana 16. Los pacientes que no respondieron al placebo fueron reasignados al azar 1:1 de manera cegada a Otezla, 20 mg dos veces al día o 30 mg dos veces al día. Los pacientes de Otezla permanecieron en su tratamiento inicial. En la Semana 24, todos los pacientes restantes con placebo fueron reasignados al azar a Otezla 20 mg dos veces al día o a Otezla 30 mg dos veces al día. Al final de las 52 semanas, los pacientes podían entrar en un estudio de extensión abierto a largo plazo por una duración total de hasta 5 años. Estos estudios no investigaron los efectos de Otezla sobre la progresión estructural.

Respuestas clínicas

El tratamiento con apremilast dio como resultado mejoras significativas en los signos y síntomas de la PsA, según lo evaluado por el criterio de respuesta ACR 20, en comparación con placebo en la Semana 16. La proporción de pacientes con respuestas ACR 20/50/70 en los estudios PALACE 1, PALACE 2 Y PALACE 3, para apremilast 30 mg dos veces al día en la Semana 16, se muestran en la Tabla 1. Las respuestas con ACR 20/50/70 se mantuvieron en la Semana 24.

Tabla 1 Proporción de Pacientes con Respuestas ACR en los Estudios PALACE 1, PALACE 2 y PALACE 3 en la Semana 16

	PALACE 1		PALACE 2		PALACE 3	
	Placebo +/- DMARDs	Apremilast 30 mg BID +/- DMARDs	Placebo +/- DMARDs	Apremilast 30 mg BID +/- DMARDs	Placebo +/- DMARDs	Apremilast 30 mg BID +/- DMARDs
N[a]	**N = 168**	**N = 168**	**N = 159**	**N = 162**	**N = 169**	**N = 167**
ACR 20						
Semana 16	19,0%	38,1%**	18,9%	32,1%*	18,3%	40,7%**
ACR 50						
Semana 16	6,0%	16,1%*	5,0%	10,5%	8,3%	15,0%
ACR 70						
Semana 16	1,2%	4,2%	0,6%	1,2%	2,4%	3,6%

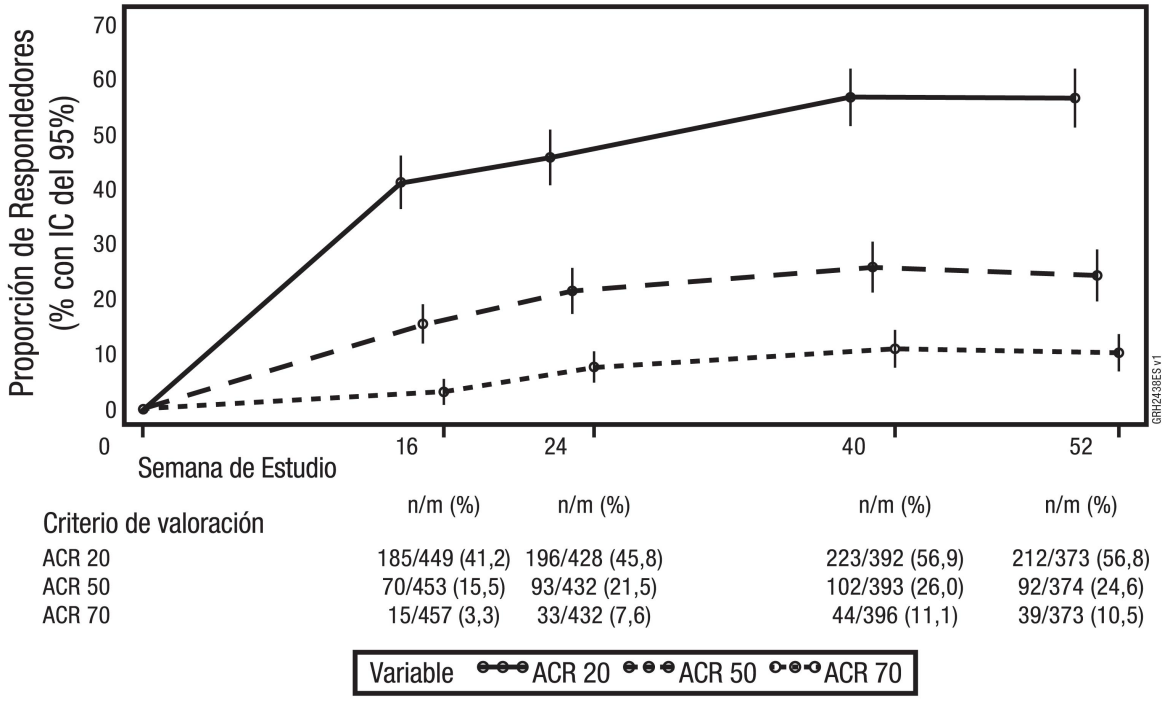
*$p \leq 0,01$ para apremilast vs. placebo.
**$p \leq 0,001$ para apremilast vs. placebo.

[a] N es el número de pacientes aleatorizados y tratados en la Semana 16.

Respuesta ACR 20/50/70 hasta la Semana 52

Entre los 497 pacientes inicialmente asignados al azar a 30 mg de apremilast dos veces al día, 373 (75%) pacientes todavía estaban en este tratamiento en la Semana 52. En estos pacientes, las respuestas ACR 20/50/70 en la Semana 52 fueron 57%, 25% y 11%, respectivamente (**Gráfico 1**).

Gráfico 1 Proporción de Respondedores ACR 20/50/70 hasta la Semana 52 en los Estudios Agrupados PALACE 1, PALACE 2 y PALACE 3



Nota: n/m es el número de respondedores/número de sujetos con datos suficientes para la determinación definitiva del estado de respuesta en cada punto de tiempo, que incluye los sujetos que discontinuaron inicialmente entre el momento previo y el momento en cuestión.

Las respuestas de ACR 20 fueron más altas en pacientes tratados con Otezla que en pacientes tratados con placebo cuando se usaron solos o en combinación con DMARD. En el estudio PALACE 1, la proporción de pacientes con una respuesta ACR 20 en la semana 16 con el uso concomitante de DMARD fue del 33,0% para Otezla 30 mg dos veces al día y 23,6% para placebo. La proporción de pacientes con una respuesta de ACR 20 a la semana 16 sin uso concomitante de DMARD fue del 46,8% para Otezla 30 mg dos veces al día y 10,3% para placebo. Se observaron resultados similares en los estudios PALACE 2 y PALACE 3.

Una mayor proporción de pacientes logró una respuesta ACR 20 con el uso de Otezla 30 mg dos veces al día, independientemente del uso previo de DMARD de molécula pequeña o de DMARD biológico. En el estudio PALACE 1, la proporción de pacientes con tratamiento previo de DMARDs de moléculas pequeñas (libres de biológicos) solamente, con una respuesta ACR 20 en la Semana 16 fue del 41,1% para Otezla 30 mg dos veces al día y de 23,3% para placebo, y la proporción de pacientes con uso previo de biológico con una respuesta ACR 20 en la Semana 16 fue del 26,8% para Otezla 30 mg dos veces al día y de 4,9% para placebo. Se observaron resultados similares en los estudios PALACE 2 y PALACE 3.

Se observaron respuestas similares al ACR 20 en pacientes con diferentes subtipos de PsA incluyendo interfalángica distal (DIP); sin embargo, el número de pacientes con artritis mutilantes y subtipos de espondilitis predominantes fue demasiado pequeño para permitir una evaluación significativa.

Otezla 30 mg dos veces al día dio como resultado un incremento en la mejoría en cada componente del ACR [número de articulaciones inflamadas y sensibles, evaluación del médico y del paciente de la

actividad de la enfermedad y la evaluación del dolor por parte del paciente, puntuaciones del Cuestionario de Evaluación Sanitaria del Índice de Discapacidad (HAQ-DI por sus siglas en inglés) y los valores de la PCR (siglas de reacción en cadena de la polimerasa)], en comparación con el placebo en las Semanas 16 y 24 en el estudio PALACE 1. Entre los pacientes que fueron continuamente tratados con Otezla, se observaron mejoras sostenidas en los componentes individuales del ACR en la Semana 52.
Se observaron resultados similares en los Estudios PALACE 2 y PALACE 3 a las Semanas 16, 24 y 52.

La proporción de pacientes que alcanzaron los criterios de respuesta de la PsA modificada (PsARC) fue significativamente mayor en el grupo de Otezla 30 mg dos veces al día en comparación con placebo a la Semana 16 (46,4% y 29,8% respectivamente, $p < 0,01$) en el estudio PALACE 1. La respuesta se mantuvo en la Semana 24. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, se observó una respuesta de la PsARC del 73,6% en la Semana 52. Se observaron resultados similares en los estudios PALACE 2 y PALACE 3 en las Semanas 16, 24 y 52.

Una mayor proporción de pacientes tratados con Otezla 30 mg dos veces al día logró la remisión, medida por un DAS28 (CRP) inferior a 2,6, en comparación con el placebo en la Semana 16 (13,1% y 3,6%, respectivamente; $p < 0,01$) en el estudio PALACE 1. La respuesta se mantuvo a la Semana 24. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, se observó una respuesta DAS28 (CRP) del 23,3% a la Semana 52. Se observaron resultados similares en los Estudios PALACE 2 y PALACE a las Semanas 16, 24 y 52.

En pacientes con entesitis o dactilitis preexistentes, el tratamiento con Otezla 30 mg dos veces al día dio como resultado una mejoría de la entesitis y la dactilitis. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, la mejora de la entesitis y la dactilitis continuó hasta la Semana 52.

Respuestas de la función física y calidad de vida relacionada con la salud
Los pacientes tratados con Otezla 30 mg dos veces al día demostraron una mejoría significativamente mayor en la función física en comparación con los pacientes tratados con placebo, como se muestra en la variación promedio del basal en la puntuación HAQ-DI en la Semana 16 (-0,244 y -0,086 respectivamente, $p < 0,01$), y en la Semana 24 (-0,258 vs. -0,076, respectivamente, $p < 0,001$) en el estudio PALACE 1. Entre los pacientes que fueron tratados continuamente con Otezla, se observó una variación promedio del basal en la puntuación HAQ-DI de -0,318 en la Semana 52. Además, hubo una mayor proporción de respondedores de HAQ-DI que mostraron mejoría ($\geq 0,3$ de mejora respecto al basal) en la Semana 16 para el grupo Otezla 30 mg dos veces al día en comparación con el grupo placebo (38,1% vs. 26,8% respectivamente $p < 0,05$). La respuesta se mantuvo en la semana 24. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, la proporción de respondedores de HAQ-DI fue del 44,7% en la Semana 52. Se observaron resultados similares en la variación promedio basal de HAQ-DI y en la proporción de HAQ-DI respondedores en los estudios PALACE 2 Y PALACE 3 en las Semanas 16, 24 y 52.

Los pacientes tratados con Otezla 30 mg dos veces al día demostraron una mejoría significativamente mayor en comparación con los pacientes tratados con placebo en la variación promedio respecto al basal en la puntuación SF-36v2 del dominio de la función física (PF por sus siglas en inglés) en la Semana 16 (4,23 y 1,81, $p < 0,01$) en el estudio PALACE 1. Se observó una mejoría mayor, en comparación con el placebo, en la variación promedio con respecto al basal en la Puntuación de Componentes Físicos (PCS por sus siglas en inglés) en la Semana 16 (4,59 y 2,39 respectivamente, $p < 0,01$). Las respuestas se mantuvieron en la Semana 24. Entre los pacientes que fueron tratados continuamente con Otezla, se observaron variaciones promedio del basal en las puntuaciones de SF-36v2 PF y PCS de 5,69 y 6,45, respectivamente, en la Semana 52. Se observaron resultados similares en los estudios PALACE 2 Y PALACE 3 en las semanas 16, 24 y 52.

No se observó empeoramiento en la variación promedio con respecto al basal en la puntuación de

Resumen de Componentes Mentales (MCS por sus siglas en inglés) en pacientes tratados con Otezla 30 mg dos veces al día, en comparación con los pacientes tratados con placebo en la Semana 16 (0,69 y 0,07, respectivamente) y en la Semana 24 en el estudio PALACE 1. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, se observó una variación promedio del basal en la puntuación de MCS de 0,34 en la Semana 52. Se observaron resultados similares en los estudios PALACE 2 y PALACE 3 en las Semanas 16, 24 y 52.

Se observó un incremento en la mejoría en las puntuaciones de la Evaluación Funcional de la Terapia de la Enfermedad Crónica – Fatiga (FACIT-fatiga por sus siglas en inglés) en los pacientes tratados con Otezla 30 mg dos veces al día en comparación con el grupo placebo en las Semanas 16 (3,88 y 1,55, respectivamente, $p < 0,05$), en el estudio PALACE 1. La respuesta se mantuvo en la Semana 24. Entre los pacientes que fueron tratados continuamente con Otezla, se observó una variación promedio con respecto al basal en la puntuación de FACIT-fatiga de 3,67 en la Semana 52. Se observaron resultados similares en los estudios PALACE 2 y PALACE 3 en las Semanas 16, 24 y 52.

Respuesta PASI-75

El tratamiento con Otezla 30 mg dos veces al día dio como resultado una mejoría en las manifestaciones cutáneas de la psoriasis. Se evaluó a los pacientes con un compromiso de psoriasis de al menos 3% de BSA, utilizando las respuestas de PASI-75. En el estudio PALACE 3, una proporción significativamente mayor de pacientes logró un PASI-75 en el grupo Otezla en comparación con el grupo placebo (22,2% y 7,9%, respectivamente; $p < 0,01$), en la Semana 16. La respuesta se mantuvo en la Semana 24. Hubo más pacientes con respuestas PASI-75 en el grupo Otezla que en los pacientes tratados con placebo, con o sin tratamiento concomitante con DMARD. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, se observó una respuesta PASI-75 del 39,1% en la Semana 52. Se observaron respuestas similares en los estudios PALACE 1 y PALACE 2 en las Semanas 16, 24 y 52.

Experiencia en Ensayo Clínico de pacientes con Artritis Psoriásica no tratados previamente con DMARD

La seguridad y la eficacia de Otezla se evaluaron en un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo (Estudio PALACE 4) en 527 pacientes adultos con PsA activa (≥ 3 articulaciones inflamadas y ≥ 3 articulaciones sensibles) que no fueron tratados previamente con DMARD. Los pacientes incluidos en este estudio tuvieron un diagnóstico de PsA durante al menos 3 meses. No se permitió el tratamiento previo con DMARDs o biológicos.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a placebo (n = 176), Otezla 20 mg (n = 175), u Otezla 30 mg (n = 176) administrados oralmente dos veces al día. Se permitió a los pacientes recibir dosis estables de prednisona (equivalente a ≤ 10 mg / día) y/o fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Se prohibió el uso de otros DMARDs, incluyendo metotrexato (MTX), sulfasalazina (SSZ), leflunomida (LEF) o biológicos. Se incluyeron pacientes con cada subtipo de PsA, incluyendo poliartritis simétrica (61,3%), oligoartritis asimétrica (30%), artritis articular distal interfalángica (DIP) (6,6%), artritis mutilante (0,8%) y espondilitis predominante (1,3%). Se inscribieron pacientes con entesitis preexistente (65%) y dactilitis preexistente (50%). La duración promedio de la enfermedad PsA fue de 1,1 años.

Los pacientes recibieron terapia concomitante incluyendo dosis bajas de corticosteroides orales (7,2%) y AINEs (73,1%); La combinación de apremilast con DMARDs de molécula pequeña o biológica no fue estudiada.

El criterio de valoración primario fue el porcentaje de pacientes que lograron la respuesta 20 del Colegio Americano de Reumatología (ACR) en la Semana 16. Los pacientes cuyos conteos de articulaciones sensibles e inflamadas no habían mejorado en al menos el 20%, fueron considerados no respondedores en la Semana 16. Los que no respondieron al placebo fueron reasignados al azar 1:1 de manera cegada a Otezla 20 mg dos veces al día o 30 mg dos veces al día. Los pacientes de Otezla

permanecieron con su tratamiento inicial. En la Semana 24, todos los pacientes restantes con placebo fueron reasignados al azar a Otezla 20 mg dos veces al día u Otezla 30 mg dos veces al día. Al final de las 52 semanas, los pacientes podían entrar en un estudio de extensión abierto a largo plazo con una duración total de hasta 5 años. Este estudio no investigó los efectos de Otezla en la progresión estructural.

Respuestas clínicas
A continuación se presenta el porcentaje de pacientes que alcanzaron las respuestas ACR 20/50/70 en la Semana 16 en el Estudio PALACE 4, en la Tabla 2. Otezla, en comparación con placebo, dio como resultado una mejora significativamente mayor en los signos y síntomas de la artritis psoriásica, como lo demuestra la proporción de los pacientes con respuesta de ACR 20 en la Semana 16. La mejora en las respuestas de ACR 50/70 también se demostró en la Semana 16. Las respuestas de ACR 20/50/70 se mantuvieron en la Semana 24.

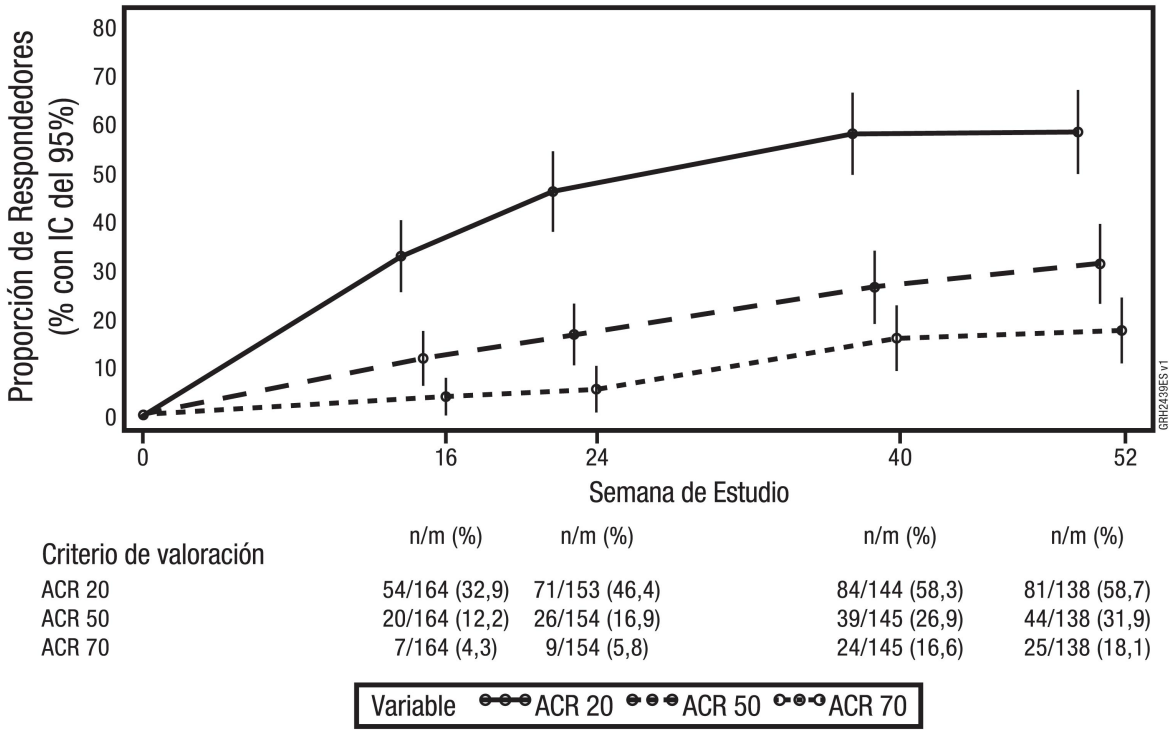
Tabla 2 Proporción de Pacientes con Respuestas ACR en la Semana 16 del Estudio PALACE 4

PALACE 4		
	Placebo	**Otezla 30 mg dos veces al día**
N[a]	176	176
ACR 20		
Semana 16	16%	31%**
ACR 50		
Semana 16	5%	11%*
ACR 70		
Semana 16	1%	4%

[a]N es el número de pacientes aleatorizados y tratados.
*p ≤ 0,05 para Otezla vs. placebo.
**p ≤ 0,001 para Otezla vs. placebo.

Respuesta ACR 20/50/70 hasta la Semana 52
Entre los 176 pacientes inicialmente asignados al azar a 30 mg de apremilast dos veces al día, 138 (78%) pacientes seguían recibiendo este tratamiento en la Semana 52. En estos pacientes, las respuestas ACR 20/50/70 en la Semana 52 fueron 59%, 32% y 18%, respectivamente (**Gráfico 2**).

Gráfico 2 Proporción de Respondedores ACR 20/50/70 hasta la Semana 52 en el estudio PALACE 4 (Datos observados)



Criterio de valoración	n/m (%)	n/m (%)	n/m (%)	n/m (%)
ACR 20	54/164 (32,9)	71/153 (46,4)	84/144 (58,3)	81/138 (58,7)
ACR 50	20/164 (12,2)	26/154 (16,9)	39/145 (26,9)	44/138 (31,9)
ACR 70	7/164 (4,3)	9/154 (5,8)	24/145 (16,6)	25/138 (18,1)

Nota: n/m es el número de respondedores/número de sujetos con datos suficientes para la determinación definitiva del estado de respuesta en cada punto de tiempo, que incluye los sujetos que discontinuaron inicialmente entre el momento anterior y el momento en cuestión.

El tratamiento con Otezla 30 mg dos veces al día dio como resultado una mejoría mayor para cada componente de la ACR (número de articulaciones inflamadas y sensibles, evaluación de la actividad de la enfermedad por el médico y el paciente y la evaluación del dolor por el paciente, puntuación HAQ-DI y valor de la PCR), en comparación con el placebo en las Semanas 16 y 24 en el estudio PALACE 4. Entre los pacientes que fueron tratados continuamente con Otezla, se observaron mejoras sostenidas en los componentes individuales de ACR en la Semana 52.

La proporción de pacientes que lograron un PsARC modificado fue significativamente mayor en el grupo de Otezla 30 mg dos veces al día comparado con el placebo en la Semana 16 (45,5% y 24,4%, respectivamente; $p < 0,001$) en el estudio PALACE 4. La respuesta se mantuvo en la Semana 24. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, la respuesta modificada de PsARC fue del 75,9% en la Semana 52.

En pacientes con entesitis o dactilitis preexistentes, el tratamiento con Otezla 30 mg dos veces al día dio como resultado una mejoría de la entesitis y la dactilitis, en comparación con placebo en la Semana 16. Las respuestas se mantuvieron en la Semana 24. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, se observó una mejoría sostenida de la entesitis y la dactilitis durante la Semana 52.

Respuestas de la función física y calidad de vida relacionada con la salud

Los pacientes tratados con Otezla 30 mg dos veces al día demostraron una mejoría significativamente mayor en la función física en comparación con los pacientes tratados con placebo, como se muestra en la variación promedio con respecto a la línea de base en la puntuación HAQ-DI en la Semana 16

(−0,205 y -0,012, respectivamente; p < 0,001), y en la Semana 24 (-0,207 vs. -0,012, respectivamente; p < 0,001) en el Estudio PALACE 4. Entre los pacientes que fueron tratados continuamente con Otezla, la variación promedio con respecto al basal en la puntuación HAQ-DI fue de -0,392 en la Semana 52. Además, hubo una mayor proporción de respondedores de HAQ-DI que mostraron mejoría (≥ 0,3 mejora con respecto al valor basal) en la Semana 16 para el grupo de Otezla 30 mg dos veces al día en comparación con el grupo placebo (34,7% y 19.3%, respectivamente). La respuesta se mantuvo en la Semana 24. Entre los pacientes que fueron tratados continuamente con Otezla, la proporción de respondedores de HAQ-DI fue del 48,9% en la Semana 52.

El tratamiento con Otezla 30 mg dos veces al día demostró una mejoría significativamente mayor, en comparación con el placebo, en la variación promedio con respecto al basal en el SF-36v2 PF en la Semana 16 (3,19 y 0,01, respectivamente; p < 0,001) en el estudio PALACE 4. Además, el tratamiento con Otezla 30 mg dos veces al día demostró una mejoría mayor, en comparación con el placebo en la variación promedio con respecto al basal en el PCS en la Semana 16 (4,20 y 0,93, respectivamente; p < 0,001). Las respuestas se mantuvieron en la Semana 24. Entre los pacientes que se trataron continuamente con Otezla, se observó una variación promedio con respecto al basal en las puntuaciones de SF-36v2 PF y PCS de 6,41 y 6,67, respectivamente, en la Semana 52.

No se observó un empeoramiento en la variación promedio con respecto al basal en el SF-26v2MCS en la Semana 16 y en la Semana 24 en el estudio PALACE 4. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla 30 mg dos veces al día, la variación promedio con respecto al basal en la puntuación SF-36v2 MCS fue de 2,19 en la Semana 52.

Se observó una mayor mejoría en las puntuaciones de la Evaluación Funcional de la Terapia de la Enfermedad Crónica – Fatiga (FACIT-fatiga) en el grupo Otezla en comparación con el grupo placebo en las Semanas 16 (2,62 y 0,07, respectivamente; p < 0,01), en el estudio PALACE 4. La respuesta se mantuvo en la Semana 24. Entre los pacientes que fueron tratados continuamente con Otezla, se observó una variación promedio con respecto al basal en la puntuación de FACIT-fatiga de 5,89 en la Semana 52.

Respuesta PASI-75
El tratamiento con Otezla 30 mg dos veces al día dio como resultado una mejoría en las manifestaciones cutáneas de la psoriasis. Se evaluó a los pacientes con un compromiso de psoriasis de al menos 3% de BSA, utilizando las respuestas de PASI-75. En la Semana 16, una proporción significativamente mayor de pacientes logró un PASI-75 en el grupo Otezla 30 mg dos veces al día en comparación con el grupo placebo (26,6% y 10,8%, respectivamente; p < 0,01), en el estudio PALACE 4. La respuesta se mantuvo en la Semana 24. Entre los pacientes tratados continuamente con Otezla, se observó una respuesta PASI-75 del 31,9% en la Semana 52.

Experiencia en Ensayo Clínico de pacientes con Psoriasis
Se evaluó la seguridad y la eficacia de Otezla en dos estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo (Estudios ESTEEM 1 y ESTEEM 2) que incluyeron a un total de 1.257 pacientes de 18 años de edad y mayores, con Psoriasis en placas de moderada a grave, que tenían un compromiso de ≥ 10% de BSA, una puntuación de Índice de Gravedad y del Área de Psoriasis (PASI por sus siglas en inglés) de ≥ 12, una Evaluación Global Estática del Médico (sPGA por sus siglas en inglés) de ≥ 3 (moderada o grave) y que eran candidatos a fototerapia o terapia sistémica. Los estudios no incluyeron un brazo comparador activo.

Estos estudios tuvieron un diseño similar hasta la Semana 32. En ambos estudios, los pacientes fueron aleatorizados 2:1 a Otezla 30 mg dos veces al día o placebo durante 16 semanas (fase controlada con placebo) y desde las Semanas 16-32, todos los pacientes recibieron Otezla 30 mg dos veces al día (fase de mantenimiento). Durante la Fase de Retirada del Tratamiento Aleatorizado (Semanas 32-52), los pacientes inicialmente asignados al azar a Otezla que lograron una reducción de al menos un 75% en su puntuación PASI (PASI-75) (ESTEEM 1) o una reducción del 50% en su puntuación PASI (PASI-

50) (ESTEEM 2), fueron reasignados al azar en la Semana 32 a placebo o a Otezla 30 mg dos veces al día. Los pacientes que fueron reasignados al placebo y que perdieron la respuesta PASI-75 (ESTEEM 1) o perdieron el 50% de la mejora del PASI en la Semana 32 en comparación con el basal (ESTEEM 2), fueron tratados nuevamente con Otezla 30 mg dos veces al día. Los pacientes que no alcanzaron la respuesta PASI designada en la Semana 32, o que inicialmente fueron asignados al azar a placebo, permanecieron con Otezla hasta la Semana 52.

En ambos estudios, el criterio de valoración primario fue la proporción de pacientes que lograron el PASI-75 en la Semana 16. El criterio de valoración secundario principal fue la proporción de pacientes que alcanzaron una puntuación sPGA de aclaramiento (0) o casi aclaramiento (1) en la Semana 16. Otras variables incluyeron BSA, VAS (siglas en inglés de Escala Visual Análoga) del prurito, enfermedad de las uñas (NAPSI por sus siglas en inglés), compromiso del cuero cabelludo (ScPGA por sus siglas en inglés) y medidas de calidad de vida (DLQI y SF-36 MCS).

En los dos estudios, los pacientes tenían edades comprendidas entre 18 y 83 años, con una edad media general de 45,8 años. El promedio del compromiso basal de la BSA fue de 25,19% (mediana 21,0%), el promedio basal de la puntuación PASI fue de 19,07 (mediana 16,80), y la proporción de pacientes con puntuación de sPGA de 3 (moderada) y 4 (grave) en el basal fue de 70,0% y 29,8%, respectivamente. Aproximadamente el 30% de todos los pacientes habían recibido fototerapia previa y el 54% habían recibido terapia sistémica y/o biológica convencional para el tratamiento de la psoriasis (incluyendo fracasos terapéuticos), recibiendo el 37% terapia sistémica convencional previa y el 30% terapia biológica previa. Aproximadamente un tercio de los pacientes no habían recibido previamente fototerapia, terapia convencional sistémica o biológica. Un total de 18% de los pacientes tenían antecedentes de artritis psoriásica.

Respuesta clínica
La proporción de pacientes que alcanzaron las respuestas PASI-50, -75 y -90 y la puntuación sPGA de aclaramiento o casi aclaramiento, se presentan en la Tabla 3 a continuación. Otezla dio como resultado mejorías significativas en la psoriasis en placas de moderada a grave, como lo demuestra la proporción de pacientes con una respuesta PASI-75 en la Semana 16 en comparación con placebo. La mejoría clínica medida mediante las respuestas sPGA, PASI-50 y PASI-90, también se demostró en la Semana 16. Además, Otezla demostró un beneficio de tratamiento a través de múltiples manifestaciones de psoriasis, incluyendo prurito, enfermedad de las uñas, compromiso del cuero cabelludo y medidas de calidad de vida.

Tabla 3. Respuesta Clínica en la Semana 16 en los Estudios ESTEEM 1 y ESTEEM 2[a]

	ESTEEM 1		**ESTEEM 2**	
	Placebo	**30 mg dos veces al día de APR[#]**	**Placebo**	**30 mg dos veces al día de APR[#]**
N	282	562	137	274
PASI 75[b], n (%)	15 (5,3)	186 (33,1)	8 (5,8)	79 (28,8)
sPGA[c] aclaramiento o casi aclaramiento, n (%)	11 (3,9)	122 (21,7)	6 (4,4)	56 (20,4)
PASI 50, n (%)	48 (17,0)	330 (58,7)	27 (19,7)	152 (55,5)
PASI 90, n (%)	1 (0,4)	55 (9,8)	2 (1,5)	24 (8,8)
Variación Porcentual BSA[d, h] (%)	- 6,9 ± 38,95	- 47,8 ± 38,48	- 6,1 ± 47,57	-48,4 ± 40,78

	ESTEEM 1		ESTEEM 2	
	Placebo	**30 mg dos veces al día de APR[#]**	**Placebo**	**30 mg dos veces al día de APR[#]**
Variación en VAS de prurito[e, h] (mm)	- 7,3 ± 27,08	- 31,5 ± 32,43	- 12,2 ± 30,94	- 33,5 ±35,46
Variación en DLQI[f, h]	- 2,1 ± 5,69	- 6,6 ± 6,66	-2,8 ± 7,22	-6,7 ± 6,95
Variación en SF-36 MCS[g, h]	- 1,02 ± 9,161	2,39 ± 9,504	0 ±10,498	2,58 ± 10,129

- [#] p < 0,0001 para todas las comparaciones vs. placebo, excepto para ESTEEM 2 PASI 90 y la variación en SF-36 MCS donde p = 0,0042 y p = 0,0078, respectivamente.
[a] Conjunto de Análisis Completo, Última Observación Realizada
[b] PASI = Índice de Gravedad y Área de la Psoriasis
[c] sPGA = Evaluación Global Estática del Médico
[d] BSA = Superficie Corporal
[e] VAS = Escala Visual Análoga; 0 = mejor, 100 = peor
[f] DLQI = Índice Dermatológico de Calidad de Vida; 0 = mejor, 30 = peor
[g] SF-36 MCS = Resultado médico Formulario abreviado Encuesta Sanitaria de 36 ítems, Resumen del Componente Mental
[h] promedio +/- desvío estándar

El beneficio clínico de Otezla se demostró a través de múltiples subgrupos definidos por la demografía basal, las características clínicas basales de la enfermedad (incluyendo la duración de la enfermedad psoriásica y los pacientes con antecedentes de artritis psoriásica), el uso previo de medicación para la psoriasis y la respuesta a tratamientos previos contra la psoriasis. Se observaron tasas de respuesta similares en todos los rangos de peso.

En la Semana 2 se observaron mejoras significativas en comparación con el placebo en la variación promedio del PASI desde el inicio, molestias cutáneas/dolor y prurito. En general, las respuestas PASI se alcanzaron a la Semana 16 y se mantuvieron hasta la Semana 32.

Durante la Fase de Discontinuación del Tratamiento Aleatorizado (Semanas 32-52) en el Estudio ESTEEM 1, la mejora porcentual promedio en el PASI desde la línea basal, se mantuvo estable (81-88%) para los pacientes reasignados al azar a Otezla en la Semana 32. Aproximadamente el 61% de estos pacientes tuvo una respuesta PASI-75 en la Semana 52. De los pacientes reasignados al azar a placebo en la Semana 32, el 11,7% alcanzó la respuesta PASI-75 en la Semana 52. Los pacientes que fueron reasignados al placebo perdieron la respuesta PASI-75 más rápido que los pacientes reasignados a Otezla. La mediana del tiempo hasta la primera pérdida de la respuesta PASI-75 para los pacientes reasignados al azar a placebo y a Otezla en la Semana 32 fue de 5,1 y 17,7 semanas, respectivamente.

En el estudio ESTEEM 2, el 80,3% de los pacientes reasignados al azar a Otezla en la Semana 32 tuvieron una respuesta PASI-50 en la Semana 52. De los pacientes con al menos una respuesta PASI-50 que fueron reasignados al placebo en la semana 32, 24,2% fueron respondedores PASI-50 en la Semana 52. Los pacientes que fueron reasignados al azar a placebo perdieron el 50% de su respuesta PASI en la Semana 32 significativamente más rápido que los pacientes reasignados al azar a Otezla. La mediana del tiempo hasta la primera pérdida de la respuesta PASI-50 para los pacientes reasignados al azar a placebo y a Otezla en la Semana 32 fue de 12,4 y 21,9 semanas, respectivamente.

Después de la retirada aleatorizada de la terapia en la Semana 32, aproximadamente el 70% de los

pacientes en el estudio ESTEEM 1, y el 65,6% de los pacientes en el estudio ESTEEM 2, recuperaron el PASI-75 (Estudio ESTEEM 1) o el PASI-50 (Estudio ESTEEM 2), después del reinicio del tratamiento con Otezla. La duración del tratamiento fue variable y osciló entre3,4 y 22,1 semanas en el estudio ESTEEM 1 y entre 2,6 y 18,3 semanas en el estudio ESTEEM 2.

Psoriasis de las uñas
En el estudio ESTEEM 1, se detectaron mejoras significativas (reducciones) en la psoriasis de las uñas, medidas mediante la variación porcentual promedio del Índice de Gravedad de la Psoriasis en las Uñas (NAPSI por sus siglas en inglés) desde la línea de base, en pacientes que recibieron Otezla en comparación con los pacientes tratados con placebo en la Semana 16 (Otezla 30 mg dos veces al día: -22,5%, placebo: + 6,5%; $p < 0,0001$). Se observaron mejoras similares en el estudio ESTEEM 2 (Otezla 30 mg dos veces al día: -29,0%, placebo: -7,1%; $p = 0,0052$). Se observaron mejoras adicionales en la psoriasis de las uñas en pacientes tratados continuamente con Otezla, con variaciones porcentuales promedio desde la línea de base en el NAPSI en la Semana 32 de -43,6% en el estudio ESTEEM 1 y de -60,0% en el estudio ESTEEM 2.

Psoriasis del cuero cabelludo
En el estudio ESTEEM 1, se detectaron mejoras significativas en la psoriasis del cuero cabelludo con una gravedad de al menos moderada (≥ 3), medida mediante la proporción de pacientes que alcanzaron la Evaluación Global por parte del Médico de la Psoriasis del Cuero Cabelludo (ScPGA por sus siglas en inglés) de aclaramiento (0) o mínima (1) en la Semana 16, en los pacientes que recibieron Otezla en comparación con los pacientes tratados con placebo (46,5% y 17,5%, respectivamente; $p < 0,0001$). Se observaron resultados similares en el estudio ESTEEM 2 (APR 30 dos veces al día 40,9%; placebo 17,2%; $p < 0,0001$).

Calidad de vida
En los estudios ESTEEM 1 y 2, se demostraron mejoras significativas en la calidad de vida, medidas mediante el índice de calidad de vida dermatológica (DLQI por sus siglas en inglés) y el SF-36v2 MCS en pacientes que recibieron Otezla en comparación con los pacientes tratados con placebo. Además, en el Estudio ESTEEM 1, se logró una mejora significativa en el Índice del Cuestionario de Limitaciones Laborales (WLQ-25 por sus siglas en inglés) en pacientes que recibieron Otezla en comparación con placebo.

Propiedades farmacocinéticas

ACCIÓN FARMACOCINÉTICA

Absorción

Apremilast se absorbe bien con una biodisponibilidad oral absoluta de aproximadamente 73%, con concentraciones plasmáticas pico (C_{max}) que ocurren en una mediana de tiempo (t_{max}) de aproximadamente 2,5 horas. La farmacocinética de apremilast es lineal, con un aumento proporcional a la dosis en la exposición sistémica en el rango de dosis de 10 a 100 mg diarios. La acumulación es mínima cuando apremilast se administra una vez al día y es aproximadamente 53% en sujetos sanos y 68% en pacientes con psoriasis cuando se administra dos veces al día. La coadministración con alimentos no altera la biodisponibilidad; por lo tanto, apremilast puede ser administrado con o sin alimentos.

Distribución

La unión a la proteína plasmática humana de apremilast es aproximadamente un 68%. El volumen medio aparente de distribución (Vd) es de 87 L, indicativo de distribución extravascular.

Metabolismo

Apremilast se metaboliza ampliamente tanto por las vías mediadas por CYP como por otras que no

son CYP, incluyendo la oxidación, la hidrólisis y la conjugación, lo que sugiere que la inhibición de una sola vía de clearance probablemente no cause una marcada interacción droga-droga. El metabolismo oxidativo de apremilast está mediado principalmente por el CYP3A4, con contribuciones menores de CYP1A2 y CYP2A6. Apremilast es el principal componente circulante después de la administración oral. Apremilast experimenta un metabolismo extenso recuperándose sólo el 3% y 7% de la drogaadministrada en orina y heces, respectivamente. El principal metabolito circulante, M12, es el glucurónido conjugado de apremilast O-desmetilado que es inactivo.

Eliminación

El clearance plasmático de apremilast es en promedio de aproximadamente 10 litros / hora en sujetos sanos, con una vida media de eliminación terminal de aproximadamente 9 horas. Se ha observado aproximadamente un 30% de reducción en el clearance de apremilast en sujetos femeninos en comparación con los sujetos masculinos. No es necesario ajustar la dosis en las pacientes femeninas. Después de la administración oral de apremilast radiomarcado, aproximadamente el 58% y el 39% de la radiactividad se recupera en la orina y las heces, respectivamente, con una recuperación de aproximadamente 3% y 7% de la dosis radiactiva como apremilast en orina y heces, respectivamente.

Insuficiencia renal

No se han realizado estudios formales en sujetos con insuficiencia renal leve o moderada. En 8 sujetos con insuficiencia renal grave a quienes se administró una dosis única de 30 mg de apremilast, el AUC y C_{max} de apremilast aumentaron en aproximadamente 89% y 42%, respectivamente. Consulte la sección Dosis y Administración para los ajustes de dosis para pacientes con insuficiencia renal grave.

Insuficiencia hepática

La farmacocinética de apremilast y su principal metabolito M12 no se ve afectada por la insuficiencia hepática moderada o grave. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática.

CONTRAINDICACIONES:

Otezla está contraindicado:

- En pacientes con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o alguno de los excipientes.
- Durante el embarazo y en mujeres lactantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso pediátrico

No se ha establecido la seguridad y efectividad de Otezla en pacientes menores de 18 años de edad.

Uso en pacientes de edad avanzada

Otezla fue estudiado en sujetos sanos jóvenes y de edad avanzada. La exposición en los sujetos de edad avanzada (de 65 a 85 años de edad) es de alrededor de un 13% mayor en el *AUC* y es de alrededor de un 6% más alta en la C_{max} de apremilast, que en los sujetos jóvenes (de 18 a 55 años de edad).

No se observaron diferencias generales en el perfil de seguridad o eficacia de los pacientes de edad avanzada de ≥ 65 años de edad y en los pacientes más jóvenes de < 65 años de edad en los estudios clínicos.

No es necesario un ajuste de la dosis en los pacientes de edad avanzada.

Disminución de peso

En algunos pacientes el tratamiento con Otezla ha sido asociado con una disminución en el peso. Los

pacientes tratados con Otezla deben controlar su peso regularmente. Si ocurre alguna pérdida de peso clínicamente significativa o sin explicación, la pérdida de peso deberá evaluarse y debe considerarse la suspensión de Otezla (consulte la sección de Efectos Adversos).

Depresión

El tratamiento con Otezla está asociado con un incremento en la aparición de depresión. Antes de utilizar Otezla en pacientes con un historial de depresión y/o pensamientos o comportamiento suicida, los prescriptores deben sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios del tratamiento con Otezla en tales pacientes. Los pacientes, sus cuidadores y familiares deben ser aconsejados acerca de la necesidad de estar alertas en cuanto a alguna emergencia por depresión o empeoramiento de la misma, pensamientos suicidas u otros cambios en el estado de ánimo, y si tales cambios sucediesen contactar a su proveedor sanitario. Los prescriptores deben evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios de continuar con el tratamiento de Otezla si tales eventos ocurren.

Función renal

Se recomienda la evaluación de la función renal antes del inicio de Otezla.

Uso en pacientes con intolerancia a la lactosa
Los comprimidos de Otezla contienen lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia a la lactosa de Lapp o mala absorción de la glucosa-galactosa, no deben ingerir este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS:

Las reacciones adversas observadas en los pacientes tratados con Otezla se enumeran a continuación por sistema de clase de órganos (SOC por sus siglas en inglés) y la frecuencia de todas las reacciones adversas. Dentro de cada SOC y grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad.

Las reacciones adversas a la droga se determinaron en base a los datos del programa de desarrollo clínico de Otezla de Fase 3. Las frecuencias de las reacciones adversas a la droga son las reportadas en los grupos de Otezla de los cuatro estudios de Fase 3 en artritis psoriásica (n = 1.945) o los dos estudios de Fase 3 en psoriasis (N = 1.184) (la mayor frecuencia de cualquiera de los conjuntos de datos se representa en la **Tabla 4**).

Las frecuencias se definen como: muy frecuente (≥ 1/10), frecuente (≥ 1/100 a < 1/10); y poco frecuente (≥ 1/1.000 a < 1/100) o rara (≥ 1/10.000 a < 1/1.000).

Tabla 4. Resumen de Reacciones Adversas en los Estudios Clínicos de Fase 3 en Artritis Psoriásica o Psoriasis

Sistema de Clasificación de Órganos	Frecuencia	Término preferido [a]
Trastornos gastrointestinales	Muy frecuente	Diarrea
		Náuseas
	Frecuente	Vómitos
		Deposiciones frecuentes
		Dolor abdominal superior
		Enfermedad de reflujo gastroesofágico

Sistema de Clasificación de Órganos	Frecuencia	Término preferido [a]
		Dispepsia
	Poco frecuente	Hemorragia gastrointestinal
Trastornos generales y condiciones en el sitio de la administración	Frecuente	Fatiga
Trastornos del sistema inmune	Poco frecuente	Hipersensibilidad
Infecciones e infestaciones	Frecuente	Bronquitis
		Infección del tracto respiratorio superior
		Nasofaringitis
Investigaciones	Poco frecuente	Pérdida de peso
Trastornos del metabolismo y la nutrición	Frecuente	Disminución del apetito
Músculo-esquelético y tejido conectivo	Frecuente	Dolor de espalda
Trastornos del sistema nervioso	Frecuente	Migraña
		Cefalea de tensión
		Cefalea
Trastornos psiquiátricos	Frecuente	Insomnio
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinales	Frecuente	Tos
Trastornos cutáneos y del tejido subcutáneo	Poco frecuente	Erupción

[a] Los términos preferidos se codifican utilizando el MedDRA (Versión 14.0)

Las reacciones adversas más frecuentemente notificadas en los estudios clínicos de Fase 3 (Estudios PALACE 1, PALACE 2, PALACE 3, PALACE 4 y ESTEEM 1 y ESTEEM 2) han sido trastornos gastrointestinales (GI) incluyendo diarrea (15,7%) y náuseas (13,9%). Estas reacciones adversas gastrointestinales fueron en su mayoría de leve a moderada en severidad, con 0,3% de los pacientes que informaron diarrea severa y 0,3% de los pacientes que informaron náuseas severas. Estas reacciones adversas generalmente ocurrieron dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento y generalmente se resolvieron en 4 semanas. Las otras reacciones adversas más comúnmente notificadas incluyeron infecciones del tracto respiratorio superior (8,4%), cefalea (7,9%) y cefalea tensional (7,2%). En general, la mayoría de las reacciones adversas se consideraron de gravedad leve o moderada. Las reacciones adversas más frecuentes que condujeron a la interrupción durante las primeras 16 semanas de tratamiento fueron diarrea (1,7%) y náuseas (1,5%).

Descripción de reacciones adversas selectas:

Disminución de peso

El peso del paciente se midió rutinariamente en los estudios clínicos.

La pérdida de peso promedio observada en los pacientes tratados hasta 52 semanas con apremilast fue de 1,99 kg. Un total de 14,3% de los pacientes que recibieron apremilast habían observado una pérdida de peso entre el 5-10% mientras que el 5,7% de los pacientes que recibieron apremilast habían observado una pérdida de peso superior al 10%. Ninguno de estos pacientes tuvo consecuencias clínicas evidentes derivadas de la pérdida de peso. Un total de 0,1% de los pacientes tratados con

apremilast lo suspendieron debido a la reacción adversa de disminución de peso. Las disminuciones de peso superiores al 5% del peso corporal basal se observaron con mayor frecuencia en mujeres que en hombres.

Depresión

Artritis psoriásica:

Durante el período controlado con placebo de 0 a 16 semanas de los 3 ensayos clínicos controlados, el 0,9% (18/1.945) de los sujetos tratados con Otezla informaron depresión o estado de ánimo deprimido comparado con el 0,7% (5/671) tratados con placebo. Durante los ensayos clínicos, el 0,1% (4/1.945) de los sujetos tratados con Otezla suspendieron el tratamiento debido a depresión o estado de ánimo deprimido, en comparación con ninguno de los sujetos tratados con placebo (0/671). La depresión se informó como grave en el 0,2% (3/1.945) de los sujetos expuestos a Otezla, en comparación con ninguno en los sujetos tratados con placebo (0/671). Se han observado casos de comportamiento e ideas suicidas en el 0,2% (3/1.945) de los sujetos mientras recibían Otezla, en comparación con ninguno en los sujetos tratados con placebo (0/671). En los ensayos clínicos, 2 sujetos que recibieron placebo se suicidaron en comparación con ninguno de los pacientes tratados con Otezla.

Psoriasis:

Durante el período controlado con placebo de 0 a 16 semanas de los 2 ensayos clínicos controlados, el 1,2% (14/1.184) de los sujetos tratados con Otezla informó depresión en comparación con el 0,5% (2/418) tratados con placebo. Durante los ensayos clínicos, el 0,1% (1/1.184) de los sujetos tratados con Otezla suspendieron el tratamiento debido a depresión en comparación con ninguno en los sujetos tratados con placebo (0/418). La depresión se informó como grave en el 0,1% (1/1.184) de los sujetos expuestos a Otezla, en comparación con ninguno en los sujetos tratados con placebo (0/418). Se han observado casos de comportamiento suicida en el 0,1% (1/1.184) de los sujetos que recibieron Otezla, en comparación con el 0,2% (1/418) en los sujetos tratados con placebo. En los ensayos clínicos, un sujeto tratado con Otezla intentó suicidarse mientras que uno que recibió placebo se suicidó.

Seguridad en pacientes de edad avanzada

No se observaron diferencias en general en el perfil de seguridad de los pacientes de edad avanzada ≥ 65 años de edad ni en los pacientes adultos más jóvenes de < 65 años de edad en los estudios clínicos.

Interacciones: Otezla no ha sido estudiado en combinación con ciclosporina o terapias biológicas.

Efecto de Otezla sobre otros medicamentos

No hubo interacción farmacocinética entre Otezla y metotrexato. Otezla puede ser co-administrado con metotrexato.

No hubo interacción farmacocinética entre Otezla y los anticonceptivos orales que contienen etinilestradiol y norgestimato. Otezla puede tomarse con anticonceptivos orales sin interacción farmacológica clínicamente relevante.

In vitro, apremilast no es un inhibidor o inductor de las enzimas del citocromo P450. Por lo tanto, apremilast co-administrado con sustratos de enzimas CYP es poco probable que afecte el clearance y la exposición de los medicamentos que son metabolizados por las enzimas CYP.

In vitro, apremilast es un sustrato, y un inhibidor débil de la glicoproteína P (IC > 50 μM).

In vitro, apremilast tiene poco o ningún efecto inhibidor (IC_{50} > 10 μM) en Transportador de Aniones Orgánicos 1 (OAT por sus siglas en inglés) y OAT3, Transportador de Cationes Orgánicos 2 (OCT), Polipéptido Transportador de Aniones Orgánicos (OATP) 1B1 y OATP1B3 o proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP por sus siglas en inglés) y no es un sustrato para estos transportadores. Por lo tanto, las interacciones farmacológicas clínicamente relevantes son improbables cuando se co-

administra apremilast con drogas que son sustratos o inhibidores de estos transportadores.

INTERACCIONES

Efecto de otros medicamentos sobre Otezla

La coadministración de Otezla con dosis múltiples de rifampicina dio como resultado una disminución de aproximadamente 72% y 43% en el área bajo la curva del tiempo de concentración (AUC) y en la concentración sérica máxima (C_{max}) de apremilast. La exposición a apremilast disminuye cuando se administra concomitantemente con fuertes inductores del CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina, fenobarbitona, carbamazepina, fenitoína y hierba de San Juan) y puede dar como resultado una respuesta clínica reducida.

La coadministración con ketoconazol aumentó el $AUC_{0-\infty}$ y la C_{max} promedio de apremilast en aproximadamente 36% y en 5%, respectivamente, lo cual no es clínicamente significativo. Otezla puede ser co-administrado con un potente inhibidor de CYP3A4 como ketoconazol.

Carcinogénesis, mutagénesis y fertilidad

Los estudios de carcinogenicidad no mostraron evidencia de tumores relacionados con el tratamiento, luego del tratamiento oral con apremilast a niveles de exposición plasmática (AUC) que estuvieron entre 7 y 10 veces (ratones) y entre 0,1 y 1 veces (ratas) superiores a lo anticipado clínicamente.

Apremilast no es genotóxico. Apremilast no indujo mutaciones en un ensayo Ames ni aberraciones cromosómicas en cultivos de linfocitos de sangre periférica humana en presencia o ausencia de activación metabólica. Apremilast no fue clastogénico en un ensayo *in vivo* de micronúcleos en ratón con dosis de hasta 2.000 mg/kg/día.

Efectos sobre la fertilidad

No hay datos sobre la fertilidad disponibles en humanos.

En un estudio de fertilidad con ratón masculino, apremilast en dosis orales de 1, 10, 25 y 50 mg/kg/día no produjo efectos en la fertilidad masculina; el nivel de efecto adverso no observado (NOAEL por sus siglas en inglés) para la fertilidad masculina fue superior a 50 mg/kg/día (3 veces la exposición clínica).
En un estudio combinado de fertilidad en el ratón femenino y en un estudio de toxicidad embrionario-fetal con dosis orales de 10, 20, 40 y 80 mg/kg/día, se observó una prolongación de los ciclos estrales y un aumento del tiempo hasta el apareamiento a 20 mg/kg/día y por encima; a pesar de esto, todas las tasas de ratones apareados y de embarazo no se vieron afectadas. El nivel de efecto no observado (NOEL) para la fertilidad femenina fue de 10 mg/kg/día (1,0 veces la exposición clínica).

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Uso durante el embarazo (Categoría de embarazo B3)

No hay estudios adecuados y bien controlados de Otezla en mujeres embarazadas.

Otezla está contraindicado en mujeres embarazadas y no debe utilizarse en mujeres que intentan quedar embarazadas.

Apremilast no fue teratogénico en ratones o monos. Otros efectos de apremilast en el embarazo incluyeron pérdida embrionario-fetal en ratones y monos, y pesos fetales reducidos y osificación retardada en ratones, a dosis superiores a la dosis humana máxima actualmente recomendada. No se

observaron tales efectos cuando la exposición en animales fue de 1,3 veces la exposición clínica.

En un estudio combinado de fertilidad del ratónfemenino y toxicidad en el desarrollo embrionario-fetal, el NOEL materno y de desarrollo observado fue de 10 mg/kg/día (1,3 veces la exposición clínica). No se observaron malformaciones del desarrollo relacionadas con el tratamiento hasta la dosis más alta de 80 mg/kg/día (4,0 veces la exposición clínica).

En un estudio de toxicidad en el desarrollo embrionario-fetal del mono, las dosis orales de 20, 50, 200 y 1.000 mg/kg/día dieron como resultado un aumento relacionado con la dosis en la pérdida prenatal (abortos) a la dosis de 50 mg/kg/día o más; no se observó ningún efecto en la pérdida prenatal a 20 mg/kg/día (1,4 veces la exposición clínica) relacionado con el producto en estudio. No se observaron efectos o malformaciones fetales en el desarrollo del mono hasta la dosis más alta de 1.000 mg/kg/día en el estudio (3,5 veces la exposición clínica) relacionados con el tratamiento.

En un estudio pre y postnatal, en el que apremilast se administró por vía oral a ratoneshembras preñadas, se observaron signos clínicos de toxicidad materna asociados con el parto de crías en un ratón en cada dosis de 80 y 300 mg/kg/día. Se observó un aumento de la mortalidad prematura y postnatal y una reducción del peso corporal de las crías durante la primera semana de lactancia a ≥ 80 mg/kg/día (≥ 4,0 veces la exposición clínica). El NOEL en el ratón para la toxicidad materna y la generación F1 fue de 10 mg/kg/día (1,3 veces el AUC clínico [siglas en inglés de Área bajo la Curva]).

Uso durante la lactancia

Apremilast fue detectado en la leche de los ratones amamantados.

Se desconoce si apremilast o sus metabolitos se excretan en la leche humana. Por lo tanto, el uso de Otezla está contraindicado en las madres que están amamantando.

Efectos sobre la habilidad para conducir y utilizar maquinarias

No se han desarrollado estudios sobre la habilidad para conducir y utilizar maquinarias.

DOSIFICACIÓN Y GRUPO ETARIO

El tratamiento con Otezla debe iniciarse por especialistas expertos en el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis o la artritis psoriásica.

La dosis recomendada de Otezla es de 30 mg dos veces al día, tomadas oralmente, aproximadamente cada 12 horas. A continuación se muestra un esquema de titulación inicial requerido, en la **Tabla 5**. No se requiere de una re-titulación después de la titulación inicial.

Tabla 5: Esquema de Titulación de la Dosis

Día 1	Día2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6 y en adelante	
AM	**AM**	**PM**	**AM**	**PM**	**AM**	**PM**	**AM**	**PM**	**AM**	**PM**
10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	30 mg	30 mg	30 mg

Los comprimidos de Otezla deben tragarse enteros, con o sin alimentos. Los comprimidos no deben ser triturados, partidos o masticados.

Si los pacientes olvidan una dosis, la próxima dosis debe tomarse tan pronto como sea posible. Si se aproxima al momento de la siguiente dosis, no se debe tomar la dosis olvidada y la siguiente debe tomarse a la hora normal.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve. Hay datos limitados sobre la insuficiencia renal moderada. Otezla debe reducirse a 30 mg una vez al día en pacientes con insuficiencia renal grave (clearance de creatinina inferior a 30 ml por minuto estimado por la ecuación de Cockcroft-Gault). Para la titulación inicial de la dosis en este grupo, se recomienda que apremilast se titule utilizando sólo el esquema AM listado en la **Tabla 5** y que se omitan las dosis PM.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. La seguridad de Otezla no se evaluó en pacientes con PsA o PSOR con insuficiencia hepática.
En caso de eventos adversos intolerables, debe considerarse la interrupción o suspensión de Otezla.

VIA ADMINISTRACIÓN: Oral

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO:

Otezla se estudió en sujetos sanos con una dosis diaria total máxima de 100 mg (administrada a razón de 50 mg dos veces al día) durante 4,5 días, sin indicios de toxicidad limitante de la dosis. Debe manejarse a los pacientes mediante atención sintomática y de apoyo en caso de sobredosis.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:
Almacenar a temperatura no mayor de 30°C.

PRESENTACIÓN:

Envase de inicio de tratamiento conteniendo: 27 comprimidos recubiertos (4 de 10 mg, 4 de 20 mg y 19 de 30 mg).

Envase conteniendo 56 comprimidos recubiertos (30 mg)

Comprimido recubierto de 10 mg, con forma de rombo, de color rosa, de 8 mm de largo, con “APR” grabado en una cara y “10” en la otra cara.

Comprimido recubierto de 20 mg, con forma de rombo, de color marrón, de 10 mm de largo, con “APR” grabado en una cara y “20” en la otra cara.

Comprimido recubierto de 30 mg, con forma de rombo, de color beige, de 12 mm de largo, con “APR” grabado en una cara y “30” en la otra cara.

CONDICION DE VENTA: Venta con fórmula médica

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD

Versión 1, Marzo 2021